

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

olaratumab 0.5g

(라트루보주10밀리그램/밀리리터(올라라투맙, 유전자재조합),한국틸리(유))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1바이알(50mL) 중 olaratumab 500mg

☐ **효능 효과 :**

- 조직학적 하위유형이 안트라사이클린-함유 요법에 적합하고 방사선요법이나 수술을 통한 근치적 치료를 적용할 수 없는 성인 연조직 육종의 치료를 위해 독소루비신과 병용하여 사용

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제13차 약제급여평가위원회 : 2017년 10월 27일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2017년 7월 12일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 [REDACTED] 원/바이알 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음

※ 2017년 제13차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “조직학적 하위유형이 안트라사이클린-함유 요법에 적합하고 방사선요법이나 수술을 통한 근치적 치료를 적용할 수 없는 성인 연조직 육종 환자의 치료를 위해 독소루비신과 병용”에 허가받은 약제로, doxorubicin 단독 대비 무진행생존기간 (PFS), 전체생존기간 (OS) 등이 개선되었으므로 임상적 유용성 개선이 인정되나, 소요비용이 고가임

▪ 다만, 치료적 위치가 동등한 제품(치료법)이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 약제로, 대상 환자가 소수로 근거생산이 곤란하며, 제외국 3개국 이상에 등재되어 있어 경제성평가 자료 제출 생략가능 약제에 해당하나, 제 외국 등재가격을 고려 시 수용 곤란하므로 비급여함

✓ 제약사가 A7 조정최저가 ([REDACTED] 원/바이알) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

- 기타사항

▪ [REDACTED]

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “조직학적 하위 유형이 안트라사이클린-함유요법에 적합하고 방사선 요법이나 수술을 통한 근치적 치료를 적용할 수 없는 성인 연조직 육종 환자의 치료를 위해 독소루비신과 병용”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제가 공고¹⁾되어 있어 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조 (진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 PDGFR- α 길항제로, 교과서 및 임상진료지침에서 doxorubicin과 병용요법으로 연조직육종 치료에 추천되고 있음²⁾³⁾⁴⁾
- 신청품 + doxorubicin 요법은 doxorubicin 단독요법 대비 무진행생존기간, 전체생존기간에서 유의한 개선을 보임
 - 이전에 안트라사이클린 계열 약제 치료를 받지 않은 18세 이상 조직학적으로 확진받은 국소 진행성 또는 전이성 연조직 육종환자 (n=15)를 대상으로 한 1b상 임상시험에서는 안전성을 평가하였고 Safety Review Committee (SRC)가 안전성 결과를 승인함
 - 다기관, 무작위 배정, doxorubicin 대조, 2상 임상시험(n=133)을 수행한 결과⁵⁾
 - ✓ 일차유효성평가지표인 무진행생존기간은 신청품+doxorubicin 요법군에서 6.6개월로 doxorubicin 단독요법군 4.1개월 대비 유의하게 연장되었고(HR 0.67, 95% CI 0.44-1.02, P=0.0615⁶⁾), 이차유효성평가지표인 전체생존기간은 신청품+doxorubicin 요법군에서 26.5개월(95% CI 20.9-31.7)로 doxorubicin 단독요법군에서 14.7개월(95% CI 9.2-17.1)대비 유의한 개선을 보임(HR 0.46, 95% CI 0.30-0.71, P=0.0003).
 - ✓ Grade 3 이상의 febrile neutropenia(발열성 호중구 감소증)는 신청품군과 doxorubicin 투여군에서 유사하게 나타남 (13%(8/64) vs. 14%(9/65))
- 관련 학회⁷⁾⁸⁾⁹⁾에 의하면, 신청품은 doxorubicin 단독요법과 비교하여 부작용 발생이나 독성의 유의미한 증가 없이 12개월에 가까운 생존기간 연장 효과를 보이며 임상적 유용성을 개선시킨 유일한 약제임

○ 비용 효과성

- 교과서¹⁰⁾, 임상진료지침¹¹⁾, 급여기준, 학회의견¹²⁾¹³⁾ 등을 토대로 항암화학요법으로 공고되어있는 doxorubicin 단독요법, AIM 요법¹⁴⁾, MAID 요법¹⁵⁾을 대체 가능요법으로 선정함
- 신청품+doxorubicin 병용요법의 1주기(21일) 소요비용(■■■■원)은 대체요법의 소요비용 (■■■■원 - ■■■■원) 대비 고가임
- 신청품은 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정」 제6조의 2에 따른 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당함

- 치료적 위치가 동등한 제품 (치료법)이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 항암제로, 대상 환자가 소수로 근거생산이 곤란하고 제외국 3개국 이상에 등재됨

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 해당약제의 대상 환자수는 약 [REDACTED]명¹⁷⁾이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원으로 예상되고, 신청품은 doxorubicin과 병용 투여하는 요법으로, 대체가능요법의 대체로 재정소요금액은 연도별 절대재정소요금액만큼 증가될 것으로 예상됨

※ 신청품의 대상 환자수 및 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 영국, 독일, 이탈리아에 등재되어 있음

○ 기타 사항

- [REDACTED]

Reference

- 1) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항, 개정, 공고 제 2017-213호(2017.10.1.시행)
- 2) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology(10th) > Chapter 90. Soft Tissue Sarcoma
- 3) NCCN guideline. version 2. 2017. Soft tissue sarcoma
- 4) ESMO guideline committee. 2017. Soft tissue sarcoma treatment recommendations
- 5) Tap W D et al. Olaratumab and doxorubicin versus doxorubicin alone for treatment of soft-tissue sarcoma: an open-label phase 1b and randomised phase 2 trial. 2016. The Lancet. 388 (10043) 488-97.
- 6) P value($P=0.0615$)는 미리 설정된 significance level 0.1999를 만족하였음
- 7) 대한암학회 (), ()
- 8) 대한종양내과학회 (), ()
- 9) 대한항암요법연구회 ()
- 10) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology(10th) > Chapter 90. Soft Tissue Sarcoma
- 11) NCCN guideline. version 2. 2017. Soft tissue sarcoma
- 12) 대한암학회 (), ()
- 13) 대한종양내과학회 (), ()
- 14) AIM 요법: doxorubicin + Ifosfamide + Mesna 병용요법
- 15) MAID 요법: doxorubicin + Ifosfamide + Dacarbazine + Mesna 병용요법
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임 (보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17)
- 18) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: 바이알, 2차년도: 바이알, 3차년도: 바이알)